

36 - 01- Prise en charge hygiéno-diététique et médicamenteuse (les laxatifs) - Pr. SAMLANI

(0:00 - 0:30)

La constipation chronique, prise en charge d'éthique et médicamenteuse. La constipation chronique est fréquente, elle est d'ordre de 2 à 30 %, la population générale, et augmente avec l'âge. Les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un sex ratio de 2 pour 1. La constipation est définie comme une diminution de la fréquence des selles qui sont peu volumineuses de faible poids.

(0:31 - 1:25)

Elle reconnaît deux phénomènes physiopathologiques, soit un ralentissement du transit colique, suite à un obstacle ou à un trouble du péristaltisme, soit une insensibilité rectale au phénomène de distension, c'est une constipation terminale. Dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, la classification de ROM, ROM4, définit le syndrome de l'intestin irritable et constipation comme étant une douleur abdominale chronique, au moins un jour par semaine dans les trois derniers mois, associée avec au moins deux des points suivants, un en relation avec la défécation, deux associés avec une modification de la fréquence des selles, de l'aspect des selles. Plus simplement, on parle de constipation quand on est insatisfait à la défécation, quand les selles sont trop rares ou trop difficiles à évacuer, ou les deux.

(1:25 - 2:01)

Quels sont les enjeux de la constipation ? C'est d'abord les complications dues à la constipation, notamment proctologiques, la qualité de vie, ce sont des patients qui souffrent en silence bien souvent, qui font de l'automédication, et ceci a un impact socio-économique, ce qui met l'accent sur la nécessité d'une prise en charge optimiste. La prise en charge repose d'abord sur l'exclusion d'une constipation secondaire, et sur la conduite adaptée d'un traitement médical. Il faut savoir également indiquer les explorations complémentaires spécifiques.

(2:02 - 2:21)

Donc le traitement médical fait partie de la prise en charge de la constipation. Les traitements reposent sur les laxatifs certainement, mais il faut aussi noter le rôle très important des règles hygiénothétiques. Dans notre consultation, nous prenons le temps d'expliquer le régime au patient.

(2:21 - 3:08)

Nous lui conseillons de prendre un litre et demi d'eau par jour, avec des fibres, du son de blé, du pain au son, des carrés de fibres vendus en pharmacie. Nous conseillons également de prendre

des fruits frais, des légumes frais, des fruits secs tels que des pruneaux ou des figues, et bien sûr d'éviter certains aliments qui ont la réputation de constiper, le riz, les céleri, les choux, les légumes qui entraînent surtout des balbutiements, des flatulences, les carottes cuites, les bananes et le chocolat. Il faut insister également sur la manière de manger, bien mastiquer les aliments au milieu des repas, prendre les repas à heure fixe et au calme, et prendre le temps de prendre son petit déjeuner, avec un grand verre d'eau, un jus d'orange, pour déclencher le réflexe gastrocolique.

(3:10 - 3:26)

Il y a également une manière d'aller à la salle. Il faut éduquer son côlon, aller à des heures fixes, ne jamais se retenir, et choisir une position adéquate. La meilleure position est celle que l'on voit ici, à droite, le semisquati.

(3:27 - 3:56)

Cette position a la particularité d'ouvrir l'angle anorectal. Vous avez sur cette diapositive les fibres solubles. C'est celles qu'on retrouve dans l'avoine, dans l'orge, dans le psyllium, dans le sarrasin, dans les légumineuses, dans les figues sèches, dans les pruneaux, mais également dans les carottes, les courgettes, les asperges, les patates douces, les fraises, la pamplemousse, la nectarine, la pêche, l'orange.

(3:57 - 4:21)

Et il y a ce qu'on appelle les fibres insolubles, qu'on retrouve dans le blé entier et ses dérivés, qu'on retrouve dans les graines de lin, les brocolis, les choux de Bruxelles, les amandes, les pois chiches, les lentilles et la pomme de terre. Les règles hygiénothétiques sont naturellement acceptées par le patient. Elles sont source de culpabilisation si échec, mais n'ont cependant qu'une efficacité limitée.

(4:22 - 4:41)

Bien manger améliore la qualité de vie, améliore bien sûr les flatulences, améliore le syndrome de l'intestin héritable et permet d'avoir une certaine amélioration de la constipation. Mais ce n'est pas tout. On a souvent besoin de donner un traitement médical.

(4:44 - 5:12)

Le traitement médical repose sur les laxatifs et sur les mucilages. Les laxatifs et les mucilages ont pour but d'augmenter la fréquence des selles, de modifier leur consistance et limiter les efforts de poussée, mais ils ont cette particularité de pouvoir donner également des ballonnements des flatulences et d'aggraver les symptômes liés à l'intestin héritable. Quels laxatifs est-ce qu'on peut utiliser ? Nous disposons des différentes classes.

(5:13 - 5:27)

Les laxatifs oraux, ce sont les laxatifs osmotiques, les mucilages, les émoullants, les stimulants. Les laxatifs parvoirecta, ce sont les suppositoires et les lavements. Et en première intention, nous préconisons toujours de prendre les osmotiques et les mucilages.

(5:28 - 5:55)

Les laxatifs osmotiques attirent l'eau dans la lumière colique, donnant des selles qui sont plus volumineuses, qui sont plus belles, plus molles. Deux sous-spécialités existent. On a d'abord les sucres inabsorbables, qui sont le lactulose, le lactitol, le manitol, le sorbitol, qui sont fermentissibles, c'est-à-dire qui vont potentiellement fermenter dans le tube digestif, ce qui peut provoquer une flatulence.

(5:56 - 6:12)

Et on a les autres, les macrogoles, les plus commercialisés, c'est le transipex, le forlax et le movicole. Alors tous ces laxatifs ont un bon profit de tolérance, mais peuvent donner quand même des bains. Les mucilages sont appelés des laxatifs du lest.

(6:12 - 6:49)

Ce sont des substances qui augmentent de volume en présence d'eau, qui vont donner une matière fécale plus souple et plus belle et plus volumineuse. Le plus connu, c'est le spagulax, les fibres alimentaires, telles que le son de blé, mrelin, les mucilages extraits d'algues, l'agar-agar et les gommes, sterculia, garaïa ou goire. Ce que vous voyez ici, c'est une substance qui va augmenter de taille et qui va bien sûr donner une selle qui sera plus belle, qui sera plus moulée et plus facile à évacuer.

(6:50 - 7:11)

Les principaux effets indésirables, ce sont les flatulences, les ballonnements et les bouchons. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a une sténose. On recommande aux patients de boire tout le temps pour augmenter la taille progressivement de cette selle et donc aller avec des petites doses et boire et augmenter progressivement la prise.

(7:13 - 7:20)

Troisième catégorie, ce sont les laxatifs émoullients. Ce sont des laxatifs dits aussi lubrifiants. On les donne souvent en deuxième intention.

(7:20 - 7:45)

Après les laxatifs osmotiques et les mucilages, ils sont surtout donnés en automédication. Leurs

principaux effets indésirables de ces lubrifiants, c'est le souhaitement anal qu'on dit aussi solide et les pneumopathies d'inhalation qui sont rares mais qui sont graves, qu'on peut retrouver surtout chez les patients en réanimation. S'il leur donne des lubrifiants, ils peuvent inhaler, ce qui peut entraîner des pneumopathies extrêmement graves.

(7:47 - 8:03)

C'est le cas de l'huile de paraffine. C'est une huile minérale à base de paraffine de vaseline qui a un effet mécanique parce qu'elle va lubrifier le contenu colique et donner des selles qui sont poly. Les effets indésirables, comme on l'a dit, sont les souhaitements et les pneumopathies.

(8:03 - 8:18)

C'est pour ça qu'on les garde en général en deuxième intention. Mais il faut savoir qu'ils peuvent être utiles dans certaines constipations résistantes chez des patients cancéreux par exemple. Autre catégorie, ce sont les laxatifs stimulants ou purgatifs.

(8:18 - 8:24)

Purgatifs comme purges. Ce sont des laxatifs qui ont une action motrice et sécrétoire. Deux classes.

(8:25 - 8:56)

Les hétérosides anthraquinones, comme le cas de la poudre de séné, les extraits de cascara et celloside. Et les dérivés d'éphénylméthane, ce sont les glyzacodyl ou l'huile de ressa. Ce sont des substances qui vont agir en augmentant la motricité colique, mais qui vont avoir également un autre effet qui est celui d'une absorption d'eau.

(8:57 - 9:15)

Ils ont cette particularité qui va augmenter ce péristaltisme, mais ils peuvent également irriter la muqueuse, ce qui peut entraîner à terme des problèmes au niveau de la muqueuse colique. Alors vous voyez sur cette diapositive un tableau. Vous avez les anthraquinones, la poudre de séné, la poudre de cascara.

(9:16 - 9:50)

Leur propriété pharmacologique stimule la motricité avec une action illimitée, mais ils ont des effets indésirables. Ils peuvent entraîner des élèves de dépendance, c'est-à-dire que le patient s'il n'en prend plus, va rester constipé, sa constipation risque d'être aggravée. Ils peuvent entraîner des pertes entérales et rénales de potassium, entraîner ce qu'on appelle une mélanose colique à terme, ou dite aussi une maladie de laxatif, entraîner des diarrhées à forte dose, et entraîner aussi des érectites ou des brûlures anales, secondairement à l'inflammation et l'irritation qu'ils

provoquent.

(9:50 - 10:08)

Vous avez en deuxième catégorie les dérivés du diphénylméthane, le bisacodyl. Ils ont également une action au niveau de la motricité, mais en cas de surdosage peuvent entraîner des pertes hydroélectrolytiques et des lésions des ampoules pérocytes. C'est le cas également de l'huile de ricin.

(10:09 - 10:24)

Dernière catégorie, ce sont les laxatifs par voie rectale. Les laxatifs par voie rectale sont donnés dans des situations particulières quand il y a un problème de constipation terminale, de troubles d'évacuation. Leur acceptabilité est au cas par cas.

(10:25 - 10:56)

Souvent les patients ne veulent pas, la efficacité est bonne, c'est une excellente solution à promouvoir, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de lésions proctologiques, et il faut faire attention aussi à ne pas provoquer une lésion proctologique quand on introduit la sonde ou la canule. Nous avons ici un récapitulatif des différentes classes. En premier, l'laxatif du lest, qu'on peut, pour les indications utilisées pour le traitement de fond, de toutes les constipations qui sont bien tolérées, à part qui peuvent provoquer des ballonnements et des flatulences.

(10:57 - 11:25)

L'laxatif osmotique, qui peut être utilisé également pour les constipations sévères en traitement occasionnel, avec un risque de ballonnement également. Les laxatifs stimulants, qui ont comme principaux effets secondaires l'hypocalémie, la déshydratation et bien sûr l'irritation. Et l'laxatif émoullant, dit aussi lubrifiant, dont les principaux effets indésirables sont le soignement anal et bien sûr l'irritation.

(11:26 - 12:04)

Et l'laxatif recto, qui sont intéressants chez les sujets âgés et chez les jeunes enfants, qui méritent d'être utilisés essentiellement pour les constipations terminales et qui peuvent avoir également un effet starter pour la défécation, surtout chez les sujets âgés, quand on craint qu'il n'y ait un fécal. En conclusion, il est important de savoir que le traitement de la constipation repose d'abord et d'abord sur les règles hygiénothétiques, que les laxatifs sont très utiles, mais qu'il faut savoir les prescrire à bon escient et bien sûr connaître leurs effets indésirables.